

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Revisão Flash • SESSÃO 11

Trauma Abdominal, Pélvico e Choque

O essencial para a prova em uma página



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

UnibH Vespasiano

8º PERÍODO • 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR • *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Trauma abdominal, pelve e choque

Leitura de 5 minutos

EM UMA FRASE

Reconheça o choque antes da hipotensão, ache o sangue (tórax, abdome, pelve, retroperitônio), feche a pelve nos trocânteres, transfunda cedo e leve o instável à hemostasia, não à TC.

- | | |
|---|---|
| <p>1 PA normal não absolve: lactato, déficit de base e índice de choque $\geq 0,9-1,0$.</p> | <p>2 Respondedor transitório = sangramento persistente: acelere a fonte.</p> |
| <p>3 Instável + FAST positivo: controle da fonte, sem TC.</p> | <p>4 Instável + FAST negativo: procure no tórax, pelve e retroperitônio.</p> |
| <p>5 Binder nos grandes trocânteres, nunca nas cristas ilíacas.</p> | <p>6 Hipotensão permissiva: PAS 80–90 sem TCE; no TCE, não.</p> |
| <p>7 Sequência rápida: até 3 laringoscopias; confirmar com CO₂ expirado.</p> | <p>8 Não intubo e não oxígeno: cricotireoidostomia (pele vertical, membrana horizontal).</p> |

ESPIRAL LETAL

COMPONENTE	CORRIGIR COM
<i>Hipotermia</i>	Aquecer
<i>Acidose</i>	Perfusão
<i>Coagulopatia</i>	Sangue, TXA
<i>Hipocalcemia</i>	Cálcio

PEGADINHA

Choque neurogênico é hipotensão com bradicardia. Choque medular é perda de reflexos.

CHECKLIST ANTES DA PROVA

- ☐ Reconheço o choque antes da hipotensão
- ☐ Interpreto FAST positivo e negativo
- ☐ Sei as indicações de laparotomia
- ☐ Sei quando cabe o tratamento não operatório
- ☐ Sei colocar o binder pélvico
- ☐ Sei os 5 eixos do controle de danos
- ☐ Sei a sequência rápida e a cricotireoidostomia